

Załącznik B.176.

LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE (ICD-10: G12.2)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1. Kryteria kwalifikacji Do leczenia tofersenem kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie poniższe kryteria: 1) wiek: 18 lat i powyżej; 2) rozpoznanie postaci genetycznej stwardnienia zanikowego bocznego (ALS, <i>amyotrophic lateral sclerosis</i>) spowodowanej mutacją w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 SOD1 potwierdzoną badaniem genetycznym; 3) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie wyników badań laboratoryjnych krwi zgodnie z zapisami aktualnej ChPL; 4) brak przeciwwskazań do nakłucia lędźwiowego; 5) brak istotnych chorób współistniejących stanowiących przeciwwskazanie do terapii stwierdzonych przez lekarza prowadzącego w oparciu o aktualną ChPL; 6) wykluczenie ciąży lub karmienia piersią. Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci wymagający kontynuacji leczenia, którzy byli leczeni dotychczas w ramach innego sposobu finansowania terapii, za wyjątkiem trwających badań klinicznych, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia tofersenem spełniali kryteria kwalifikacji do	1. Dawkowanie leku w programie Sposób podawania oraz ewentualne czasowe wstrzymania leczenia, prowadzone zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) lub przyjętą praktyką kliniczną. Maksymalnie finansuje się 100 mg tofersenu na podanie. Leczenie należy rozpocząć od 3 dawek nasycających podawanych w odstępach 14-dniowych. Następnie należy podawać dawkę podtrzymującą raz na 28 dni. W przypadku pacjentów wymagających znieczulenia ogólnego do wykonania nakłucia lędźwiowego - znieczulenie ogólne zgodnie z obowiązującymi w ośrodku procedurami.	1. Badania przy kwalifikacji 1) badanie genetyczne w kierunku genetycznej postaci ALS w przypadku braku wcześniejszego wyniku; 2) oznaczenie stężenia aminotransferazy alaninowej; 3) oznaczenie stężenia aminotransferazy asparaginianowej; 4) oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi; 5) oznaczenie eGFR we krwi; 6) morfologia krwi z rozmazem; 7) koagulogram (APTT, PT, TT, fibrynogen, płytki krwi); 8) oznaczenie wskaźnika BMI; 9) spirometria lub gazometria tętnicza; 10) tomografia komputerowa głowy; 11) test ciążowy (oświadczenie o stosowaniu skutecznej antykoncepcji w trakcie trwania terapii - u kobiet w wieku reprodukcyjnym); 12) konsultacja neurologiczna z oceną stopnia ciężkości choroby w skali ALSFRS-R (ang. <i>Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale</i>) wraz z określeniem wartości przy rozpoczynaniu leczenia oraz zmiany w ciągu ostatnich 3 miesięcy jeśli te dane są dostępne.

programu lekowego. 2. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do momentu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia w pkt.3. Przed wyłączeniem z programu lekowego lekarz prowadzący może wystąpić o opinię do Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii. 3. Kryteria wyłączenia z programu 1) stopień ciężkości choroby, w którym terapia nosi znamiona uporczywej; 2) pojawienie się przeciwwskazań do leczenia wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 3) pojawienie się przeciwwskazań do nakłucia lędźwiowego; 4) drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego; 5) wystąpienie chorób lub stanów, które uniemożliwiają kontynuację leczenia; 6) wystąpienie działań niepożądanych, które uniemożliwiają kontynuację leczenia; 7) wystąpienie nadwrażliwości na lek lub substancję pomocniczą uniemożliwiające kontynuację leczenia; 8) wystąpienie zagrażającej życiu albo nieakceptowalnej toksyczności pomimo zastosowania adekwatnego postępowania; 9) ciąża lub karmienie piersią; 10) brak współpracy lub nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich ze strony świadczeniobiorcy lub jego prawnych opiekunów w szczególności dotyczących okresowych badań kontrolnych		2. Monitorowanie leczenia Przed podaniem każdej dawki tofersenu: 1) badanie dna oka; 2) oznaczenie wskaźnika BMI; 3) oznaczenie stężenia aminotransferazy alaninowej; 4) oznaczenie stężenia aminotransferazy asparaginianowej; 5) oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi; 6) oznaczenie eGFR we krwi; 7) morfologia krwi z rozmazem; 8) koagulogram (APTT, PT, TT, fibrynogen, płytki krwi); 9) test ciążowy – dotyczy kobiet w wieku reprodukcyjnym. Ocenę stopnia ciężkości choroby w skali ALSFRS-R wykonuje się co 3 miesiące. 3. Monitorowanie programu 1) gromadzenie w dokumentacji medycznej pacjenta danych dotyczących monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawienie na żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia; 2) uzupełnienie danych zawartych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez OW NFZ, z częstotliwością zgodną z opisem programu oraz na zakończenie leczenia; w tym przekazywanie danych dotyczących wskaźników efektywności: a) wynik w skali ALSFRS-R przy rozpoczynaniu leczenia, b) wynik w skali ALSFRS-R podczas oceny skuteczności; 3) przekazywanie informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych
--	--	--

oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.		do NFZ: informacje przekazuje się do NFZ w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
---	--	--